Operat��r Soru Bankas�� ��� Almanca + T��rk��e

- Operatör soru bankası — Almanca + Türkçe
- Fallbeispiel 1: Herr Wagner — Bakım temelleri ve bakım süreci
- Fallbeispiel 2: Herr Brandt — İletişim modelleri
- Fallbeispiel 3: Frau Lehmann — Dokunma, yakınlık ve mesafe
- Fallbeispiel 4: Can — El hijyeni
- Fallbeispiel 5: Enfeksiyon, MRSA ve iğne batması
- Fallbeispiel 6: Lea — Hücre ve doku
- Fallbeispiel 7: Frau Ostermann — Cilt ve dekubitus
- Fallbeispiel 8: Frau Neumann — Vücut ısısı ve ateş
- Fallbeispiel 9: Herr Bauer — Hareketlilik ve düşme
- Fallbeispiel 10: Herr Yıldız — Tromboz profilaksisi
- Fallbeispiel 11: Herr Scholz — Pnömoni profilaksisi
- Fallbeispiel 12: Frau Richter — Temel yaşam desteği (BLS) ve AED
- Fallbeispiel 13: Şok ve akut hastalıklar
- Fallbeispiel 14: Dokümantasyon
- Fallbeispiel 15: Yeterlilik ve yasal temel (PflBG)

Operatör soru bankası — Almanca + Türkçe

Format (gerçek sınav gibi): *Fallbeispiel → Aufgabe n – OPERATOR | AFB.* Her konuda **en az 5 görev** var. Her görevde: **soru (DE)**, **soru (TR)**, **kısa cevap (DE, A2–B1)**, **cevap (TR)**.

Nasıl çalışılır: Önce **cevabı kapatıp** kendi Almanca cevabınızı yazın, sonra örnekle karşılaştırın. Cevaplar bilerek **kısa ve basit** yazıldı (A2–B1); sınavda daha uzun/ayrıntılı yazabilirsiniz ama **operatöre uygun** olun:

- **NENNEN** → sadece say (kısa). **BESCHREIBEN** → tam cümleler, değerlendirme yok. **ERKLÄREN** → **weil** ile neden. **BEGRÜNDEN** → neden + örnek. **ERMITTELN** → vakadan türet. **DEFINIEREN** → tanım + özellik. **VERGLEICHEN** → benzerlik + fark. **DISKUTIEREN/STELLUNG BEZIEHEN** → Pro/Contra + karar.
- **AFB I** = bilgiyi aktar · **AFB II** = dönüştür/uygula · **AFB III** = değerlendir/üret.

Uyarı: Vakalar **kurgusaldır** (gerçek hasta yok; ölçüm değerleri uydurmadır). Cevaplar ders PDF'lerinize dayanır; rakamlar/standartlar kursunuza göre kontrol edilmelidir ⚠ (özellikle kalp masajı frekansı 100–120/dk — Folien 80–100 yazıyor). Bu bir **eğitim materyalidir**, klinik talimat değildir; ilaç/doz yok.

Konu listesi (15 vaka, 100+ görev):

1. Bakım temelleri ve bakım süreci · 2. İletişim modelleri · 3. Dokunma, yakınlık–mesafe · 4. El hijyeni · 5. Enfeksiyon, MRE, iğne batması · 6. Hücre ve doku · 7. Cilt, dekubitus · 8. Vücut ısısı, ateş · 9. Hareketlilik, düşme · 10. Tromboz profilaksisi · 11. Pnömoni profilaksisi · 12. Temel yaşam desteği (BLS), AED · 13. Şok ve akut hastalıklar · 14. Dokümantasyon · 15. Yeterlilik ve yasal temel (PflBG)

Fallbeispiel 1: Herr Wagner — Bakım temelleri ve bakım süreci

Situation (DE): Herr Wagner ist 77 Jahre alt und lebt allein. Er wird nach einem Sturz im Krankenhaus aufgenommen. Er hat Schmerzen im linken Hüftbereich und braucht Hilfe beim Aufstehen. Essen und Trinken kann er alleine. Seine Brille liegt zu Hause. Er sagt: „Ich möchte mich selbst waschen." Sein Sohn wohnt in der Nähe und besucht ihn jeden Tag.
Durum (TR): Herr Wagner 77 yaşında ve yalnız yaşıyor. Düşme sonrası hastaneye yatırılıyor. Sol kalça bölgesinde ağrısı var ve kalkarken yardıma ihtiyacı var. Yemeyi ve içmeyi kendisi yapabiliyor. Gözlüğü evde. „Kendimi yıkamak istiyorum." diyor. Oğlu yakında oturuyor ve her gün ziyaret ediyor.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei Ressourcen von Herrn Wagner.
TR: Herr Wagner'in üç kaynağını (Ressource) sayın.

> **Antwort:** 1. Er isst und trinkt alleine. 2. Er möchte mitmachen. 3. Sein Sohn wohnt in der Nähe.
> **Cevap:** 1. Tek başına yiyip içiyor. 2. Katılmak istiyor. 3. Oğlu yakında oturuyor.

Aufgabe 2 – DEFINIEREN | AFB I
Definieren Sie den Begriff „Bedürfnis".
TR: „Bedürfnis" (ihtiyaç) kavramını tanımlayın.

> **Antwort:** Ein Bedürfnis ist etwas, das ein Mensch für sein Wohlbefinden braucht. Es kann körperlich, psychisch oder sozial sein.
> **Cevap:** İhtiyaç, insanın iyi oluşu için gereken şeydir. Bedensel, ruhsal veya sosyal olabilir.

Aufgabe 3 – ZUORDNEN | AFB I
Ordnen Sie drei Informationen aus dem Fall einem ABEDL zu.
TR: Vakadan üç bilgiyi bir ABEDL'e eşleştirin.

> **Antwort:** Hilfe beim Aufstehen → ABEDL 2 „Sich bewegen können". Brille fehlt → ABEDL 11 „Für eine sichere Umgebung sorgen". Sohn kommt jeden Tag → ABEDL 12 „Soziale Bereiche sichern".
> **Cevap:** Kalkarken yardım → ABEDL 2 (hareket edebilmek). Gözlük yok → ABEDL 11 (güvenli ortam). Oğlu her gün geliyor → ABEDL 12 (sosyal alanlar).

Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie drei Pflegeprobleme oder Risiken.
TR: Üç bakım sorununu veya riski saptayın.

> **Antwort:** 1. Schmerzen und unsicheres Aufstehen: Sturzrisiko. 2. Ohne Brille sieht er schlecht. 3. Er lebt allein: Er braucht nach der Entlassung Hilfe.
> **Cevap:** 1. Ağrı ve güvensiz kalkış: düşme riski. 2. Gözlüksüz iyi görmüyor. 3. Yalnız yaşıyor: taburculuktan sonra yardıma ihtiyacı var.

Aufgabe 5 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum die Evaluation im Pflegeprozess wichtig ist.
TR: Bakım sürecinde değerlendirmenin (Evaluation) neden önemli olduğunu açıklayın.

> **Antwort:** Die Evaluation ist wichtig, weil man prüft, ob das Ziel erreicht ist. Wenn nicht, ändert man den Plan. So passt die Pflege zum Zustand des Patienten.

Cevap: Değerlendirme önemlidir, çünkü hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Ulaşılmadıysa plan değiştirilir. Böylece bakım hastanın durumuna uyar.

Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum Herr Wagner beim Waschen mitmachen soll.
TR: Herr Wagner'in yıkanırken neden katılması gerektiğini gerekçelendirin.

Antwort: Er will selbstständig bleiben. Er kann einen Teil selbst machen. Wenn er mitmacht, bleiben seine Fähigkeiten und seine Selbstbestimmung erhalten.
Cevap: Bağımsız kalmak istiyor. Bir kısmını kendisi yapabiliyor. Katılırsa yetenekleri ve özerkliği korunur.

Aufgabe 7 – ENTWICKELN | AFB III
Entwickeln Sie ein Pflegeziel für Herrn Wagner und begründen Sie es.
TR: Herr Wagner için bir bakım hedefi geliştirin ve gerekçelendirin.

Antwort: Ziel: „Herr Wagner steht in drei Tagen mit Hilfe sicher auf.“ Das Ziel passt zu seinem Wunsch. Man kann es überprüfen.
Cevap: Hedef: „Herr Wagner üç gün içinde yardımla güvenle kalkar.“ Hedef isteğine uygun. Kontrol edilebilir.

Fallbeispiel 2: Herr Brandt — İletişim modelleri

Situation (DE): Herr Brandt (70) liegt im Bett und stöhnt beim Waschen. Die Schülerin Mia sagt: „Gleich sind wir fertig, Opi.“ Herr Brandt schaut zur Wand und sagt leise: „Lassen Sie mich doch in Ruhe.“ Mia sagt später zur Praxisanleiterin: „Er ist immer so schwierig.“
Durum (TR): Herr Brandt (70) yatakta, yıkanırken inliyor. Stajyer Mia: „Hemen bitiyor, Opi (dedecik).“ diyor. Herr Brandt duvara bakıp kısık sesle: „Beni rahat bırakın.“ diyor. Mia sonra uygulama eğitmenine: „O hep çok zor biri.“ diyor.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei nonverbale Zeichen von Herrn Brandt.
TR: Herr Brandt'ın üç sözsüz (nonverbal) işaretini sayın.

Antwort: Er stöhnt. Er schaut zur Wand. Er spricht leise.
Cevap: İniyor. Duvara bakıyor. Kısık sesle konuşuyor.

Aufgabe 2 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum „Opi“ problematisch ist.
TR: „Opi“ hitabının neden sorunlu olduğunu açıklayın.

Antwort: „Opi“ ist infantilisierende Sprache. Das ist nicht respektvoll, weil Herr Brandt ein Erwachsener ist. Das verletzt seine Würde.
Cevap: „Opi“ çocuklaştırıcı dildir. Saygılı değildir, çünkü Herr Brandt yetişkindir. Onurunu zedeler.

Aufgabe 3 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie die vier Seiten der Nachricht „Lassen Sie mich in Ruhe“.
TR: „Beni rahat bırakın“ mesajının dört yönünü saptayın.

Antwort: Sachinhalt: Er will allein sein. Selbstoffenbarung: Er hat Schmerzen oder ist müde. Beziehung: Er fühlt sich nicht ernst genommen. Appell: „Hören Sie auf!“

Cevap: Sachinhalt: Yalnız kalmak istiyor. Selbstoffenbarung: Ağrısı var veya yorgun. Beziehung: Ciddiye alınmadığını hissediyor. Appell: „Durun!“

Aufgabe 4 – DEUTEN | AFB III
Deuten Sie das Verhalten von Herrn Brandt aus seiner Sicht.
TR: Herr Brandt'ın davranışını onun bakış açısından yorumlayın.

Antwort: Er hat vielleicht Schmerzen und Angst. Man hat ihm nichts erklärt. Er fühlt sich nicht respektiert. Er will Kontrolle behalten.
Cevap: Belki ağrısı ve korkusu var. Ona hiçbir şey açıklanmadı. Saygı görmediğini hissediyor. Kontrolü elinde tutmak istiyor.

Aufgabe 5 – ANWENDEN | AFB II
Formulieren Sie eine Ich-Botschaft von Mia an die Praxisanleiterin.
TR: Mia'nın uygulama eğitmenine yönelik bir Ich-Botschaft (ben-dili) cümlesi yazın.

Antwort: „Ich fühle mich unsicher, weil Herr Brandt abweist. Ich wünsche mir Hilfe, wie ich besser mit ihm sprechen kann.“
Cevap: „Kendimi güvensiz hissediyorum, çünkü Herr Brandt reddediyor. Onunla nasıl daha iyi konuşabileceğim konusunda yardım istiyorum.“

Aufgabe 6 – ENTWICKELN | AFB III
Entwickeln Sie einen besseren Satz für Mia bei der Körperpflege.
TR: Mia için beden bakımı sırasında daha iyi bir cümle geliştirin.

Antwort: „Herr Brandt, ich wasche jetzt Ihren Rücken. Haben Sie Schmerzen? Wir machen langsam.“
Cevap: „Herr Brandt, şimdi sırtınızı yıkıyorum. Ağrınız var mı? Yavaş yapıyoruz.“

Aufgabe 7 – BESCHREIBEN | AFB I
Beschreiben Sie die Axiome „Man kann nicht nicht kommunizieren“ in einem Satz.
TR: „İletişimsiz olunamaz“ aksiyomunu bir cümleyle betimleyin.

Antwort: Jedes Verhalten ist Kommunikation, auch Schweigen.
Cevap: Her davranış iletişimdir, sessizlik de.

Fallbeispiel 3: Frau Lehmann — Dokunma, yakınlık ve mesafe

Situation (DE): Frau Lehmann (85) ist ängstlich. Eine Pflegekraft kommt von hinten und fasst sie ohne Wort an die Schulter. Frau Lehmann erschrickt und ruft: „Nicht anfassen!“ Die Pflegekraft möchte ihr jetzt den Rücken waschen.
Durum (TR): Frau Lehmann (85) korkak/endişeli. Bir hemşire arkadan gelip tek söz etmeden omzuna dokunuyor. Frau Lehmann korkuyor ve „Dokunmayın!“ diye bağırıyor. Hemşire şimdi sırtını yıkamak istiyor.

Aufgabe 1 – DEFINIEREN | AFB I
Definieren Sie „Initialberührung“.
TR: „Initialberührung“ (başlangıç dokunuşu) kavramını tanımlayın.

Antwort: Eine Initialberührung ist die erste, bewusste Berührung vor einer Pflege. Zum Beispiel die Hand auf die Schulter. Sie gibt Sicherheit.
Cevap: Başlangıç dokunuşu, bakımdan önceki ilk bilinçli dokunuştur. Örneğin omuza el. Güven verir.

Aufgabe 2 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei positive Wirkungen von Berührung.
TR: Dokunmanın üç olumlu etkisini sayın.

Antwort: Sicherheit und Vertrauen. Trost. Weniger Angst und Stress.
Cevap: Güven ve emniyet. Teselli. Daha az korku ve stres.

Aufgabe 3 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum Frau Lehmann erschrickt.
TR: Frau Lehmann'ın neden korktuğunu açıklayın.

Antwort: Sie hat die Pflegekraft nicht gesehen. Die Pflegekraft hat nichts gesagt. Frau Lehmann kann die Berührung nicht verstehen und hat Angst.
Cevap: Hemşireyi görmedi. Hemşire bir şey söylemedi. Frau Lehmann dokunuşu anlayamıyor ve korkuyor.

Aufgabe 4 – ZUORDNEN | AFB I
Ordnen Sie zu: Die Pflegekraft wäscht den Rücken. Welche Distanzzone ist das?
TR: Eşleştirin: Hemşire sırtı yıkıyor. Bu hangi mesafe bölgesidir?

Antwort: Das ist die intime Zone. Man ist sehr nah. Man braucht Erlaubnis.
Cevap: Bu, intim bölgedir (intime Zone). Çok yakınız. İzin gerekir.

Aufgabe 5 – ENTWICKELN | AFB III
Entwickeln Sie eine Ankündigung für die Körperpflege.
TR: Beden bakımı için bir duyuru cümlesi geliştirin.

Antwort: „Guten Tag, Frau Lehmann. Ich bin Frau Ay. Ich möchte jetzt Ihren Rücken waschen. Darf ich?“ (Hand langsam auf die Schulter.)
Cevap: „İyi günler Frau Lehmann. Ben Frau Ay. Şimdi sırtınızı yıkamak istiyorum. İzin verir misiniz?“ (Eli yavaşça omuza koyar.)

Aufgabe 6 – DISKUTIEREN | AFB III
Diskutieren Sie: Wie viel Nähe ist in der Pflege gut?
TR: Tartışın: Hemşirelikte ne kadar yakınlık iyidir?

Antwort: Nähe gibt Vertrauen und Sicherheit. Aber zu viel Nähe kann Angst machen. Pflegekräfte brauchen auch Distanz, damit sie professionell bleiben. Wichtig ist: fragen und die Zeichen beachten.
Cevap: Yakınlık güven ve emniyet verir. Ama çok fazla yakınlık korkutabilir. Hemşireler profesyonel kalmak için mesafeye de ihtiyaç duyar. Önemli olan: sormak ve işaretleri dikkate almak.

Fallbeispiel 4: Can — El hijyeni

Situation (DE): Der Auszubildende Can betritt das Zimmer von Herrn Roth. Er trägt einen Ring und eine Uhr. Er desinfiziert die Hände mit nassen Händen etwa zehn Sekunden. Danach misst er den Blutdruck, zieht Handschuhe an und macht einen Verbandwechsel. Danach geht er ohne Desinfektion zum nächsten Zimmer.
Durum (TR): Stajyer Can, Herr Roth'un odasına giriyor. Yüzük ve saat takıyor. Elleri ıslakken yaklaşık on saniye dezenfekte ediyor. Sonra tansiyon ölçüyor, eldiven giyip pansuman yapıyor. Sonra dezenfeksiyon yapmadan diğer odaya gidiyor.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie die fünf Momente der Händedesinfektion.
TR: El dezenfeksiyonunun beş anını sayın.

Antwort: 1. Vor dem Patientenkontakt. 2. Vor aseptischen Tätigkeiten. 3. Nach Kontakt mit infektiösem Material. 4. Nach dem Patientenkontakt. 5. Nach Kontakt mit der Patientenumgebung.
Cevap: 1. Hasta temasından önce. 2. Aseptik işlemlerden önce. 3. Enfekte materyalle temastan sonra. 4. Hasta temasından sonra. 5. Hasta çevresiyle temastan sonra.

Aufgabe 2 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie drei Fehler von Can.
TR: Can'ın üç hatasını saptayın.

Antwort: 1. Er trägt Ring und Uhr. 2. Die Hände sind nass. 3. Die Einwirkzeit ist zu kurz (mindestens 30 Sekunden). 4. Nach dem Verbandwechsel desinfiziert er nicht.
Cevap: 1. Yüzük ve saat takıyor. 2. Eller ıslak. 3. Etki süresi çok kısa (en az 30 saniye). 4. Pansumandan sonra dezenfekte etmiyor.

Aufgabe 3 – BESCHREIBEN | AFB I
Beschreiben Sie die richtige Händedesinfektion.
TR: Doğru el dezenfeksiyonunu betimleyin.

Antwort: Zuerst Schmuck ablegen. Die Hände sind trocken. Man nimmt genug Mittel in die Hand. Man reibt alle Stellen ein, auch Daumen und Fingerspitzen. Das dauert mindestens 30 Sekunden.
Cevap: Önce takılar çıkarılır. Eller kuru olmalı. Avuca yeterli madde alınır. Tüm yerler ovulur, başparmak ve parmak uçları da. En az 30 saniye sürer.

Aufgabe 4 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum Handschuhe die Händedesinfektion nicht ersetzen.
TR: Eldivenlerin el dezenfeksiyonunun yerini neden tutmadığını açıklayın.

Antwort: Handschuhe können kleine Löcher haben. Beim Ausziehen können Keime an die Hände kommen. Darum muss man danach die Hände desinfizieren.
Cevap: Eldivenlerde küçük delikler olabilir. Çıkarırken mikroplar ellere bulaşabilir. Bu yüzden sonrasında eller dezenfekte edilmelidir.

Aufgabe 5 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum man bei der Arbeit keinen Schmuck trägt.
TR: Çalışırken neden takı takılmadığını gerekçelendirin.

Antwort: Unter Ringen und Uhren bleiben Keime. Das Mittel erreicht nicht alle Stellen. Dann ist die Desinfektion nicht gut.
Cevap: Yüzük ve saatin altında mikroplar kalır. Madde her yere ulaşmaz. O zaman dezenfeksiyon iyi olmaz.

Aufgabe 6 – ZUORDNEN | AFB I
Ordnen Sie zu: Reinigung – Desinfektion – Sterilisation. Welche Aussage passt?
a) alle Keime tot b) die meisten Erreger tot c) Schmutz und viele Keime entfernt
TR: Eşleştirin: temizlik – dezenfeksiyon – sterilizasyon. a) tüm mikroplar ölü b) çoğu etken ölü c) kir ve birçok mikrop uzaklaştırılmış

Antwort: Reinigung → c. Desinfektion → b. Sterilisation → a.

Cevap: Temizlik → c. Dezenfeksiyon → b. Sterilizasyon → a.

Fallbeispiel 5: Enfeksiyon, MRSA ve iğne batması

Situation (DE): Herr Albrecht (79) hat MRSA und liegt im Einzelzimmer. Er hat einen Blasenkatheter und eine chronische Wunde. Die Schülerin Lena nimmt nach einer Blutentnahme die Kanüle und steckt sie in die Schutzkappe zurück. Dabei sticht sie sich in den Finger.
Durum (TR): Herr Albrecht (79) MRSA taşıyor ve tek kişilik odada yatıyor. Mesane kateteri ve kronik yarası var. Stajyer Lena, kan almadan sonra kanülü koruyucu kapağına geri takıyor. Bu sırada parmağını batırıyor.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei Risikofaktoren für MRE bei Herrn Albrecht.
TR: Herr Albrecht'taki MRE için üç risk faktörünü sayın.

Antwort: Blasenkatheter. Chronische Wunde. Hohes Alter.
Cevap: Mesane kateteri. Kronik yara. İleri yaş.

Aufgabe 2 – DEFINIEREN | AFB I
Definieren Sie „nosokomiale Infektion“.
TR: „Nosokomiale Infektion“ (hastane enfeksiyonu) kavramını tanımlayın.

Antwort: Eine nosokomiale Infektion bekommt man im Krankenhaus oder im Pflegeheim.
Cevap: Hastane enfeksiyonu hastanede veya bakım evinde kazanılır.

Aufgabe 3 – VERGLEICHEN | AFB II
Vergleichen Sie endogene und exogene Infektionen.
TR: Endojen ve eksojen enfeksiyonları karşılaştırın.

Antwort: Beide machen Menschen krank. Bei einer endogenen Infektion kommen die Erreger aus dem Körper selbst (zum Beispiel aus dem Darm). Bei einer exogenen Infektion kommen sie von außen.
Cevap: İkisi de insanı hasta eder. Endojen enfeksiyonda etkenler vücudun kendisinden gelir (örn. bağırsak). Eksojen enfeksiyonda dışarıdan gelir.

Aufgabe 4 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum Lenas Handlung gefährlich ist.
TR: Lena'nın davranışının neden tehlikeli olduğunu açıklayın.

Antwort: Beim Zurückstecken (Recapping) kann man sich leicht verletzen. Die Kanüle ist mit Blut verschmutzt. So können Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV übertragen werden.
Cevap: Geri takarken (Recapping) kolay yaralanılır. Kanül kanla kirlenmiştir. Böylece hepatit B, hepatit C veya HIV bulaşabilir.

Aufgabe 5 – BESCHREIBEN | AFB I
Beschreiben Sie die ersten Schritte nach der Nadelstichverletzung.
TR: İğne batmasından sonraki ilk adımları betimleyin.

Antwort: Lena lässt die Wunde bluten, spült sie gut und desinfiziert sie. Dann geht sie sofort zum Arzt. Man meldet den Unfall und dokumentiert alles. Bei HIV-Risiko muss die Behandlung (PEP) in zwei Stunden beginnen.
Cevap: Lena yaranın kanamasına izin verir, iyice yıkar ve dezenfekte eder. Sonra hemen doktora gider. Kaza bildirilir ve her şey dokümante edilir. HIV riskinde tedavi (PEP) iki saat içinde başlamalıdır.

Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum man gebrauchte Kanülen sofort entsorgt.
TR: Kullanılmış kanüllerin neden hemen atıldığını gerekçelendirin.

Antwort: Man vermeidet Verletzungen und schützt sich und andere. Ein voller Behälter oder Zeitdruck erhöht das Risiko. Darum entsorgt man selbst und sofort.
Cevap: Yaralanmalar önlenir, kendiniz ve başkaları korunur. Dolu kutu veya zaman baskısı riski artırır. Bu yüzden kişi kendisi ve hemen atar.

Fallbeispiel 6: Lea — Hücre ve doku

Situation (DE): Die Schülerin Lea lernt im Unterricht „Zelle und Gewebe“. Die Lehrerin zeigt ein Bild von einer Zelle. Lea soll die Teile benennen. Danach fragt die Lehrerin: „Warum heilt eine Wunde?“
Durum (TR): Stajyer Lea derste „Hücre ve doku“ konusunu öğreniyor. Öğretmen bir hücre resmi gösteriyor. Lea parçaları adlandırmalı. Sonra öğretmen soruyor: „Bir yara neden iyileşir?“

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie die drei Hauptteile einer Zelle.
TR: Bir hücrenin üç ana parçasını sayın.

> **Antwort:** Zellmembran, Zytoplasma und Zellkern.
> **Cevap:** Hücre zarı, sitoplazma ve hücre çekirdeği.

Aufgabe 2 – ZUORDNEN | AFB I
Ordnen Sie zu: Mitochondrien – Ribosomen – Lysosomen. a) baut Abfall ab b) macht Energie (ATP) c) macht Proteine
TR: Eşleştirin: mitokondri – ribozom – lizozom. a) atığı parçalar b) enerji (ATP) üretir c) protein yapar

> **Antwort:** Mitochondrien → b. Ribosomen → c. Lysosomen → a.
> **Cevap:** Mitokondri → b. Ribozom → c. Lizozom → a.

Aufgabe 3 – DEFINIEREN | AFB I
Definieren Sie „Gewebe“.
TR: „Gewebe“ (doku) kavramını tanımlayın.

> **Antwort:** Gewebe sind viele gleiche Zellen mit einer gemeinsamen Aufgabe. Dazu gehört auch die Matrix zwischen den Zellen.
> **Cevap:** Doku, ortak görevi olan birçok benzer hücredir. Hücreler arasındaki matriks de buna dahildir.

Aufgabe 4 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie die vier Grundgewebe.
TR: Dört temel dokuyu sayın.

> **Antwort:** Epithelgewebe, Bindegewebe, Muskelgewebe und Nervengewebe.
> **Cevap:** Epitel dokusu, bağ dokusu, kas dokusu ve sinir dokusu.

Aufgabe 5 – VERGLEICHEN | AFB II
Vergleichen Sie Mitose und Meiose.
TR: Mitoz ve mayozu karşılaştırın.

> **Antwort:** Bei beiden teilt sich eine Zelle. Bei der Mitose entstehen zwei gleiche Körperzellen. Bei der Meiose entstehen vier verschiedene Keimzellen (Eizellen und Spermien).
> **Cevap:** İkisinde de bir hücre bölünür. Mitozda iki aynı vücut hücresi oluşur. Mayozda dört farklı üreme hücresi (yumurta ve sperm) oluşur.

Aufgabe 6 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum eine Wunde heilen kann.
TR: Bir yaranın neden iyileşebildiğini açıklayın.

> **Antwort:** Die Wunde heilt, weil sich Körperzellen durch Mitose teilen. So entstehen neue Zellen. Das Bindegewebe hilft bei der Wundheilung.

Cevap: Yara iyileşir, çünkü vücut hücreleri mitozla bölünür. Böylece yeni hücreler oluşur. Bağ dokusu yara iyileşmesine yardımcı olur.

Aufgabe 7 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum Epithelgewebe wichtig für die Haut ist.
TR: Epitel dokusunun cilt için neden önemli olduğunu gerekçelendirin.

Antwort: Epithel ist eine Schutzschicht. Es schützt vor Keimen und Stoffen. Es hat keine Blutgefäße und wird über Diffusion ernährt.
Cevap: Epitel bir koruyucu tabakadır. Mikroplardan ve maddelerden korur. Kan damarı yoktur ve difüzyonla beslenir.

Fallbeispiel 7: Frau Ostermann — Cilt ve dekubitus

Situation (DE): Frau Ostermann (84) liegt viel im Bett. Ihre Haut ist trocken. Am Kreuzbein sieht die Pflegekraft eine Rötung. Beim Fingerdruck bleibt die Rötung. Am Handrücken bleibt eine Hautfalte einige Sekunden stehen. Frau Ostermann hat wenig getrunken. Die Lippen sind etwas bläulich.
Durum (TR): Frau Ostermann (84) çok yatıyor. Cildi kuru. Hemşire sakrumda (Kreuzbein) bir kızarıklık görüyor. Parmakla basınca kızarıklık geçmiyor. El sırtında deri kıvrımı birkaç saniye ayakta kalıyor. Frau Ostermann az içmiş. Dudakları hafif morumsu.

Aufgabe 1 – BESCHREIBEN | AFB I
Beschreiben Sie den Hautbefund am Kreuzbein.
TR: Sakrumdaki cilt bulgusunu betimleyin.

Antwort: Am Kreuzbein ist die Haut gerötet. Die Rötung geht bei Fingerdruck nicht weg. Das ist ein positiver Fingertest.
Cevap: Sakrumda cilt kızarık. Parmak basısıyla kızarıklık geçmiyor. Bu pozitif Fingertest'tir.

Aufgabe 2 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie zwei Hinweise auf Flüssigkeitsmangel.
TR: Sıvı eksikliğine dair iki ipucu saptayın.

Antwort: 1. Die Hautfalte bleibt stehen (verminderter Turgor). 2. Frau Ostermann hat wenig getrunken. (Auch: trockene Haut.)
Cevap: 1. Deri kıvrımı ayakta kalıyor (azalmış turgor). 2. Frau Ostermann az içmiş. (Ayrıca: kuru cilt.)

Aufgabe 3 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, wie ein Dekubitus entsteht.
TR: Dekubitusun nasıl oluştuğunu açıklayın.

Antwort: Ein Dekubitus entsteht, weil lange Druck auf der Haut ist. Dann fließt wenig Blut. Das Gewebe bekommt zu wenig Sauerstoff. Oft ist das am Kreuzbein, an den Fersen oder an der Hüfte.
Cevap: Dekubitus, ciltte uzun süre baskı olduğu için oluşur. O zaman az kan akar. Doku yeterli oksijen alamaz. Çoğunlukla sakrum, topuk veya kalçada görülür.

Aufgabe 4 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie die drei Hautschichten.
TR: Üç cilt katmanını sayın.

Antwort: Oberhaut (Epidermis), Lederhaut (Dermis) und Unterhaut (Subkutis).
Cevap: Epidermis (üst deri), dermis (Lederhaut), subkutis (deri altı).

Aufgabe 5 – ZUORDNEN | AFB I
Ordnen Sie zu: Blässe – Zyanose – Ikterus. a) gelbe Haut b) blaue Lippen c) blasse Haut
TR: Eşleştirin: solukluk – siyanoz – sarılık. a) sarı cilt b) mavi dudaklar c) soluk cilt

> **Antwort:** Blässe → c. Zyanose → b. Ikterus → a.
> **Cevap:** Blässe → c. Zyanose → b. Ikterus → a.

Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum die Pflegekraft die bläulichen Lippen melden soll.
TR: Hemşirenin morumsu dudakları neden bildirmesi gerektiğini gerekçelendirin.

> **Antwort:** Blaue Lippen sind ein Zeichen für Sauerstoffmangel (Zyanose). Das kann gefährlich sein. Darum informiert die Pflegekraft sofort die Pflegefachkraft oder den Arzt.
> **Cevap:** Mavi dudaklar oksijen eksikliğinin (siyanoz) işaretidir. Tehlikeli olabilir. Bu yüzden hemşire hemen sorumlu hemşireye veya doktora haber verir.

Aufgabe 7 – ENTWICKELN | AFB III
Entwickeln Sie einen Dokumentationseintrag zum Hautbefund.
TR: Cilt bulgusu için bir dokümantasyon girişi geliştirin.

> **Antwort:** „Kreuzbein: Rötung, ca. 3 × 2 cm, nicht wegdrückbar. Haut ist nicht offen. Pflegefachkraft informiert."
> **Cevap:** „Sakrum: kızarıklık, yaklaşık 3 × 2 cm, bası ile geçmiyor. Cilt açık değil. Sorumlu hemşire bilgilendirildi."

Fallbeispiel 8: Frau Neumann — Vücut ısısı ve ateş

Situation (DE): Frau Neumann (69) hat eine Infektion. Um 14 Uhr friert sie und zittert. Ihre Haut ist blass und kalt. Die Temperatur ist 38,0 °C. Um 16 Uhr ist die Haut heiß, trocken und rot. Die Temperatur ist 39,2 °C. Sie hat Durst und Kopfschmerzen. Sie bittet: „Bitte kalte Wickel!"
Durum (TR): Frau Neumann (69) enfeksiyonlu. Saat 14'te üşüyor ve titriyor. Cildi soluk ve soğuk. Isı 38,0 °C. Saat 16'da cilt sıcak, kuru ve kırmızı. Isı 39,2 °C. Susamış ve baş ağrısı var. „Lütfen soğuk kompres!" diyor.

Aufgabe 1 – ZUORDNEN | AFB I
Ordnen Sie die Uhrzeiten den Fieberstadien zu.
TR: Saatleri ateş evrelerine eşleştirin.

> **Antwort:** 14 Uhr: Fieberanstieg. 16 Uhr: Fieberhöhe.
> **Cevap:** Saat 14: ateş artışı. Saat 16: ateş zirvesi.

Aufgabe 2 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum Frau Neumann um 14 Uhr friert.
TR: Frau Neumann'ın saat 14'te neden üşüdüğünü açıklayın.

> **Antwort:** Der Körper stellt den Sollwert höher. Er will die neue Temperatur erreichen. Darum sind die Gefäße eng, die Haut ist kalt, und die Muskeln zittern.
> **Cevap:** Vücut hedef değeri yükseltir. Yeni ısıya ulaşmak ister. Bu yüzden damarlar dardır, cilt soğuktur ve kaslar titrer.

Aufgabe 3 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei Orte für die Temperaturmessung.

TR: Isı ölçümü için üç yeri sayın.

> **Antwort:** Im Ohr, unter der Achsel, im Po (rektal). (Auch: unter der Zunge.)
> **Cevap:** Kulakta, koltuk altında, makatta (rektal). (Ayrıca: dil altı.)

Aufgabe 4 – VERGLEICHEN | AFB II
Vergleichen Sie rektale und axillare Messung.
TR: Rektal ve axillar ölçümü karşılaştırın.

> **Antwort:** Beide messen die Temperatur. Rektal ist sehr genau und zeigt die Kerntemperatur. Axillar ist einfach, aber misst nur die Schalentemperatur. Rektal ist unangenehm und verletzt die Intimsphäre.
> **Cevap:** İkisi de ısıyı ölçer. Rektal çok doğrudur ve çekirdek ısıyı gösterir. Axillar basittir ama sadece kabuk ısısını ölçer. Rektal rahatsız edicidir ve mahremiyeti zedeler.

Aufgabe 5 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum man im Fieberanstieg nicht kühlt.
TR: Ateş artışında neden soğutulmadığını gerekçelendirin.

> **Antwort:** Der Körper will warm werden. Kälte macht mehr Schüttelfrost. Darum wärmt man den Patienten mit Decken.
> **Cevap:** Vücut ısınmak ister. Soğuk daha fazla titreme yapar. Bu yüzden hasta battaniyelerle ısıtılır.

Aufgabe 6 – ANWENDEN | AFB II
Wenden Sie Ihr Wissen an: Beschreiben Sie einen Wadenwickel um 16 Uhr.
TR: Bilginizi uygulayın: Saat 16'da bir baldır kompresini betimleyin.

> **Antwort:** Man legt zwei Tücher in lauwarmes Wasser (nicht zu kalt), wringt sie aus und legt sie locker um die Waden. Nach 5–10 Minuten wechselt man die Tücher. Man macht das nur nach Absprache mit der Pflegefachkraft oder dem Arzt.
> **Cevap:** İki bez ılık suya (çok soğuk değil) batırılır, sıkılır ve baldırlara gevşekçe sarılır. 5–10 dakika sonra bezler değiştirilir. Bu sadece sorumlu hemşire veya doktorla anlaşarak yapılır.

Aufgabe 7 – DEUTEN | AFB III
Deuten Sie: Nach dem Fieber hat die Patientin kalten, klebrigen Schweiß und blasse Haut. Was bedeutet das?
TR: Yorumlayın: Ateşten sonra hastada soğuk, yapışkan ter ve soluk cilt var. Bu ne anlama gelir?

> **Antwort:** Das kann eine Krisis sein. Das Fieber fällt zu schnell. Der Kreislauf ist schwach, und es besteht Gefahr für einen Kollaps. Das ist ein Notfall. Man informiert sofort den Arzt.
> **Cevap:** Bu bir Krisis (ani ateş düşüşü) olabilir. Ateş çok hızlı düşüyor. Dolaşım zayıf ve kollaps tehlikesi var. Bu bir acildir. Hemen doktora haber verilir.

Fallbeispiel 9: Herr Bauer — Hareketlilik ve düşme

Situation (DE): Herr Bauer (83) benutzt einen Rollator. Nachts steht er auf und geht zur Toilette. Er trägt lockere Hausschuhe und ist schwindelig, weil er neue Tabletten bekommen hat. Im Bad stürzt er. Er sitzt auf dem Boden, hat Schmerzen am Handgelenk und hat Angst.
Durum (TR): Herr Bauer (83) rolatör kullanıyor. Geceleri kalkıp tuvalete gidiyor. Gevşek terlik giyiyor ve yeni ilaçlar aldığı için başı dönüyor. Banyoda düşüyor. Yerde oturuyor, bileğinde ağrı var ve korkuyor.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei Sturzursachen bei Herrn Bauer.

TR: Herr Bauer'deki üç düşme nedenini sayın.

Antwort: Schwindel durch Tabletten. Lockere Hausschuhe. Nachts zur Toilette gehen (Dunkelheit, Eile).
Cevap: İlaçlara bağlı baş dönmesi. Gevşek terlikler. Geceleri tuvalete gitmek (karanlık, acele).

Aufgabe 2 – DEFINIEREN | AFB I
Definieren Sie „Sturz“.
TR: „Sturz“ (düşme) kavramını tanımlayın.

Antwort: Ein Sturz ist ein Ereignis. Man kommt ohne Absicht auf dem Boden oder tiefer an.
Cevap: Düşme, istemeden yere ya da daha alçak bir seviyeye gelme olayıdır.

Aufgabe 3 – BESCHREIBEN | AFB I
Beschreiben Sie, was die Pflegekraft nach dem Sturz macht.
TR: Hemşirenin düşmeden sonra ne yaptığını betimleyin.

Antwort: Sie beruhigt Herrn Bauer und ruft Hilfe. Sie schaut nach Verletzungen. Wenn kein Bruch möglich ist, hilft sie beim Aufstehen. Sie misst Puls und Blutdruck. Sie füllt das Sturzprotokoll aus und informiert Arzt und Angehörige.
Cevap: Herr Bauer'i sakinleştirir ve yardım çağırır. Yaralanmalara bakar. Kırık mümkün değilse kalkmasına yardım eder. Nabız ve tansiyonu ölçer. Sturzprotokoll'ü doldurur, doktoru ve yakınları bilgilendirir.

Aufgabe 4 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum Angst vor einem Sturz ein Problem ist.
TR: Düşme korkusunun neden bir sorun olduğunu açıklayın.

Antwort: Wer Angst hat, bewegt sich weniger. Dann werden die Muskeln schwächer. Das Sturzrisiko steigt. Er verliert auch Selbstständigkeit.
Cevap: Korkan kişi daha az hareket eder. O zaman kaslar zayıflar. Düşme riski artar. Bağımsızlığını da kaybeder.

Aufgabe 5 – ENTWICKELN | AFB III
Entwickeln Sie zwei Maßnahmen für eine sichere Umgebung.
TR: Güvenli bir ortam için iki önlem geliştirin.

Antwort: 1. Nachts ein Licht mit Bewegungsmelder und Stolperfallen weg. 2. Feste, rutschfeste Schuhe. (Auch: Bremsen am Rollator schließen, Haltegriffe im Bad.)
Cevap: 1. Geceleri hareket sensörlü ışık ve takılma tehlikelerini kaldırmak. 2. Sağlam, kaymaz ayakkabılar. (Ayrıca: rolatör frenleri kilitli, banyoda tutunma kolları.)

Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum man ein Sturzprotokoll schreibt.
TR: Neden Sturzprotokoll yazıldığını gerekçelendirin.

Antwort: Man sieht, was passiert ist. Man findet Ursachen und kann neue Stürze verhindern. Es ist ein Nachweis für Qualität und Verantwortung.
Cevap: Ne olduğu görülür. Nedenler bulunur ve yeni düşmeler önlenebilir. Kalite ve sorumluluk için bir kanıttır.

Aufgabe 7 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie zwei Zeichen, die in den nächsten 24 Stunden wichtig sind.
TR: Önümüzdeki 24 saatte önemli olan iki işareti saptayın.

Antwort: Zeichen für Gehirnerschütterung: Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel. Zeichen für Hirndruck: Pupillen reagieren nicht auf Licht; hoher Blutdruck und niedriger Puls.
Cevap: Beyin sarsıntısı işaretleri: baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi. Kafa içi basınç işaretleri: pupiller ışığa tepki vermez; yüksek tansiyon ve düşük nabız.

Fallbeispiel 10: Herr Yıldız — Tromboz profilaksisi

Situation (DE): Herr Yıldız (68) hatte vor zwei Tagen eine Knie-Operation. Er liegt viel im Bett und trinkt wenig. Er raucht. Heute sagt er: „Mein linkes Bein ist schwer, und es tut weh.“ Das Bein ist geschwollen und warm.
Durum (TR): Herr Yıldız (68) iki gün önce diz ameliyatı oldu. Çoğu zaman yatakta ve az içiyor. Sigara içiyor. Bugün: „Sol bacağım ağır ve ağrıyor.“ diyor. Bacak şiş ve sıcak.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie die drei Faktoren der Virchow-Trias.
TR: Virchow üçlüsünün üç faktörünü sayın.

Antwort: Langsamer Blutfluss, Schäden an der Gefäßwand und mehr Gerinnung im Blut.
Cevap: Yavaş kan akışı, damar duvarı hasarı ve kanda artmış pıhtılaşma.

Aufgabe 2 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie drei Risikofaktoren für eine Thrombose bei Herrn Yıldız.
TR: Herr Yıldız'daki tromboz için üç risk faktörünü saptayın.

Antwort: Operation, wenig Bewegung (Immobilität), Rauchen. (Auch: Alter über 60, wenig trinken.)
Cevap: Ameliyat, az hareket (immobilite), sigara. (Ayrıca: 60 yaş üstü, az içme.)

Aufgabe 3 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum Bewegung gegen Thrombose hilft.
TR: Hareketin tromboza karşı neden yardımcı olduğunu açıklayın.

Antwort: Bei Bewegung arbeiten die Beinmuskeln. Sie pumpen das Blut zum Herzen (Muskel-Venen-Pumpe). Dann fließt das Blut schneller. Das verhindert Gerinnsel.
Cevap: Hareket sırasında bacak kasları çalışır. Kanı kalbe pompalar (kas-ven pompası). O zaman kan daha hızlı akar. Bu pıhtıları önler.

Aufgabe 4 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum die Pflegekraft jetzt sofort die Pflegefachkraft oder den Arzt informiert.
TR: Hemşirenin neden hemen sorumlu hemşireyi veya doktoru bilgilendirdiğini gerekçelendirin.

Antwort: Das Bein zeigt Zeichen einer Thrombose (schwer, geschwollen, warm). Ein Gerinnsel kann in die Lunge gehen. Das ist eine Lungenembolie und lebensgefährlich.
Cevap: Bacakta tromboz belirtileri var (ağır, şiş, sıcak). Pıhtı akciğere gidebilir. Bu akciğer embolisidir ve yaşamı tehdit eder.

Aufgabe 5 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei Basismaßnahmen der Thromboseprophylaxe.
TR: Tromboz profilaksisinin üç temel önlemini sayın.

Antwort: Frühmobilisation. Bewegungsübungen (zum Beispiel Füße kreisen). Genug trinken.
Cevap: Erken mobilizasyon. Hareket egzersizleri (örn. ayakları daire çizdirmek). Yeterince içmek.

Aufgabe 6 – STELLUNG BEZIEHEN | AFB III
Nehmen Sie Stellung: „Beine hochlegen und ausstreichen schützt vor Thrombose."
TR: Görüş bildirin: „Bacakları yukarı koymak ve sıvazlamak tromboza karşı korur."

Antwort: Das stimmt nicht. Hochlegen hilft nur für das Wohlbefinden, nicht gegen Thrombose. Ausstreichen kann ein Gerinnsel lösen. Das ist gefährlich. Besser: Bewegung, trinken und Strümpfe nach Plan.
Cevap: Bu doğru değil. Yukarı koymak sadece rahatlık içindir, tromboza karşı değil. Sıvazlama pıhtıyı koparabilir. Bu tehlikelidir. Daha iyisi: hareket, içme ve plana göre çorap.

Aufgabe 7 – BESCHREIBEN | AFB I
Beschreiben Sie, wann man keine Thromboseprophylaxestrümpfe (MTPS) benutzt.
TR: Tromboz profilaksi çoraplarının (MTPS) ne zaman kullanılmadığını betimleyin.

Antwort: Man benutzt sie nicht bei schlechter Durchblutung der Arterien, bei starker Nervenschädigung, bei starken Ödemen und bei offenen Wunden oder Nekrosen am Bein.
Cevap: Atardamar dolaşım bozukluğunda, ağır sinir hasarında, belirgin ödemde ve bacakta açık yara veya nekrozda kullanılmaz.

Fallbeispiel 11: Herr Scholz — Pnömoni profilaksisi

Situation (DE): Herr Scholz (81) hatte einen Schlaganfall. Er hat eine Schluckstörung. Beim Essen im Liegen verschluckt er sich und hustet oft. Er liegt viel im Bett und atmet flach. Heute hat er Fieber und Atemnot. Seine Lippen sind leicht blau.
Durum (TR): Herr Scholz (81) inme geçirdi. Yutma bozukluğu var. Yatarken yemek yerken boğuluyor ve sık öksürüyor. Çok yatıyor ve yüzeysel soluyor. Bugün ateşi ve nefes darlığı var. Dudakları hafif mavi.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie zwei Risikofaktoren für eine Pneumonie bei Herrn Scholz.
TR: Herr Scholz'daki pnömoni için iki risk faktörünü sayın.

Antwort: Schluckstörung (Aspiration). Wenig Bewegung und flache Atmung.
Cevap: Yutma bozukluğu (aspirasyon). Az hareket ve yüzeysel solunum.

Aufgabe 2 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie das LISA-Prinzip.
TR: LISA prensibini açıklayın.

Antwort: L: Lungenbelüftung verbessern. I: Infektionen vermeiden. S: Sekret lösen und entleeren. A: Aspiration vermeiden.
Cevap: L: Akciğer havalandırmasını iyileştirmek. I: Enfeksiyonları önlemek. S: Sekreti çözmek ve boşaltmak. A: Aspirasyonu önlemek.

Aufgabe 3 – BESCHREIBEN | AFB I
Beschreiben Sie, wie man Herrn Scholz beim Essen schützt.
TR: Herr Scholz'u yemek sırasında nasıl koruduğunuzu betimleyin.

Antwort: Er sitzt aufrecht beim Essen. Man gibt ihm viel Zeit. Er isst nicht im Liegen. Bei Husten oder Atemnot hört man auf und holt Hilfe.
Cevap: Yemek sırasında dik oturur. Ona çok zaman verilir. Yatarken yemez. Öksürük veya nefes darlığında durulur ve yardım çağrılır.

Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie drei Zeichen für eine Aspirationspneumonie.
TR: Aspirasyon pnömonisi için üç belirtiyi saptayın.

Antwort: Husten, Atemnot, blaue Lippen (Zyanose). Später kommt Fieber.
Cevap: Öksürük, nefes darlığı, mavi dudaklar (siyanoz). Sonra ateş gelir.

Aufgabe 5 – VERGLEICHEN | AFB II
Vergleichen Sie typische und atypische Pneumonie.
TR: Tipik ve atipik pnömoniyi karşılaştırın.

Antwort: Beide sind Lungenentzündungen. Typisch: plötzlicher Beginn, hohes Fieber mit Schüttelfrost, produktiver Husten. Atypisch: langsamer Beginn, leichtes Fieber, trockener Husten.
Cevap: İkisi de akciğer iltihabıdır. Tipik: ani başlangıç, titremeli yüksek ateş, balgamlı öksürük. Atipik: yavaş başlangıç, hafif ateş, kuru öksürük.

Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum man den Oberkörper hochlagert.
TR: Gövdenin neden yükseltildiğini gerekçelendirin.

Antwort: Mit hohem Oberkörper atmet man leichter. Die Atemmuskeln arbeiten besser, und die Lunge wird besser belüftet.
Cevap: Gövde yüksekken daha kolay nefes alınır. Solunum kasları daha iyi çalışır ve akciğer daha iyi havalanır.

Aufgabe 7 – ENTWICKELN | AFB III
Entwickeln Sie zwei Maßnahmen für die Atmung.
TR: Solunum için iki önlem geliştirin.

Antwort: 1. Mundpflege und Hygiene (Infektionen vermeiden). 2. Zum Sitzen oder Gehen helfen und viel trinken lassen (Sekret lösen). Bei Atemnot sofort die Pflegefachkraft informieren.
Cevap: 1. Ağız bakımı ve hijyen (enfeksiyonu önlemek). 2. Oturmaya veya yürümeye yardım etmek ve çok içirmek (sekreti çözmek). Nefes darlığında hemen sorumlu hemşire bilgilendirilir.

Fallbeispiel 12: Frau Richter — Temel yaşam desteği (BLS) ve AED

Situation (DE): Sie arbeiten im Krankenhaus. Im Flur liegt Frau Richter (70) am Boden. Sie reagiert nicht auf Ansprechen. Sie atmet nicht normal, nur ab und zu schnappt sie nach Luft. Ein AED hängt an der Wand.
Durum (TR): Hastanede çalışıyorsunuz. Koridorda Frau Richter (70) yerde yatıyor. Seslenmeye tepki vermiyor. Normal solumuyor, sadece ara sıra hava için çırpınıyor. Duvarda bir AED asılı.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie die ersten Schritte.
TR: İlk adımları sayın.

Antwort: Eigene Sicherheit prüfen. Ansprechen und anfassen. Hilfe rufen. Atemweg öffnen. Atmung prüfen (höchstens 10 Sekunden).
Cevap: Kendi güvenliğini kontrol et. Seslen ve dokun. Yardım çağır. Hava yolunu aç. Solunumu kontrol et (en fazla 10 saniye).

Aufgabe 2 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum das Schnappen nach Luft keine normale Atmung ist.
TR: Hava için çırpınmanın neden normal solunum olmadığını açıklayın.

Antwort: Das ist eine Schnappatmung. Sie kommt bei einem Kreislaufstillstand vor. Der Körper bekommt dabei nicht genug Luft. Darum beginnt man sofort mit der Wiederbelebung.
Cevap: Bu bir Schnappatmung'dur (agonal solunum). Dolaşım durmasında görülür. Vücut yeterli hava alamaz. Bu yüzden hemen resüsitasyona başlanır.

Aufgabe 3 – BESCHREIBEN | AFB I
Beschreiben Sie die Herzdruckmassage beim Erwachsenen.
TR: Erişkinde kalp masajını betimleyin.

Antwort: Frau Richter liegt auf hartem Boden. Man drückt in der Mitte des Brustkorbs. Die Arme sind gestreckt. Man drückt 5 bis 6 cm tief, 100 bis 120 Mal pro Minute. Dann 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen. Nach 2 Minuten wechselt man.
Cevap: Frau Richter sert zeminde yatıyor. Göğsün ortasına basılır. Kollar düzdür. 5–6 cm derinlikte, dakikada 100–120 kez basılır. Sonra 30 kez bas, 2 kez soluk ver. 2 dakika sonra kişi değişir. (⚠ Slaytlarda 80–100/dk da var; öğretmene sorun.)

Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie, was man beim Notruf sagt.
TR: Acil çağrıda neyin söylendiğini saptayın.

Antwort: Wo ist es? Wer ruft an? Was ist passiert? Wie viele Personen sind betroffen? Dann wartet man auf Rückfragen.
Cevap: Nerede? Kim arıyor? Ne oldu? Kaç kişi etkilendi? Sonra karşı tarafın sorularını bekler.

Aufgabe 5 – VERGLEICHEN | AFB II
Vergleichen Sie: Bewusstlos mit normaler Atmung und bewusstlos ohne normale Atmung.
TR: Karşılaştırın: Normal solunumlu bilinçsiz kişi ve normal solunumsuz bilinçsiz kişi.

Antwort: Bei beiden ruft man Hilfe. Mit normaler Atmung legt man die Person in die stabile Seitenlage und kontrolliert die Atmung. Ohne normale Atmung beginnt man sofort mit der Herzdruckmassage.
Cevap: İkisinde de yardım çağrılır. Normal solunum varsa kişi stabil yan yatışa alınır ve solunum kontrol edilir. Normal solunum yoksa hemen kalp masajına başlanır.

Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum der AED die Herzdruckmassage nicht ersetzt.
TR: AED'nin kalp masajının yerini neden tutmadığını gerekçelendirin.

Antwort: Der AED gibt nur bei einem bestimmten Rhythmus einen Schock. Die Herzdruckmassage hält den Kreislauf aufrecht. Beides zusammen gibt die beste Chance.
Cevap: AED yalnızca belirli bir ritimde şok verir. Kalp masajı dolaşımı sürdürür. İkisi birlikte en iyi şansı verir.

Aufgabe 7 – STELLUNG BEZIEHEN | AFB III
Nehmen Sie Stellung: „Ich bin Auszubildende. Ich darf bei einem Notfall nichts tun.“
TR: Görüş bildirin: „Ben stajyerim. Acilde hiçbir şey yapamam.“

Antwort: Das stimmt nicht. Nach § 323c StGB muss man helfen, wenn es möglich ist. Eine Auszubildende hilft nach ihren Kenntnissen, ruft Hilfe und informiert die Pflegefachkraft. Wer mit Sorgfalt hilft, hat normalerweise keine rechtlichen Probleme.
Cevap: Bu doğru değil. § 323c StGB'ye göre mümkünse yardım edilmelidir. Stajyer bilgisi ölçüsünde yardım eder, yardım çağırır ve sorumlu hemşireyi bilgilendirir. Özenle yardım eden kişinin normalde hukuki sorunu olmaz. (⚠ hukuki tavsiye değil)

Fallbeispiel 13: Şok ve akut hastalıklar

Situation (DE): Herr Berg (71) sagt: „Ich habe starke Schmerzen in der Brust. Der Schmerz geht in den linken Arm.“ Er schwitzt kalt, ist blass und hat Angst. In einem anderen Zimmer hat Frau Vogel (74) plötzlich einen hängenden Mundwinkel und spricht undeutlich.
Durum (TR): Herr Berg (71): „Göğsümde şiddetli ağrı var. Ağrı sol kola yayılıyor.“ diyor. Soğuk terliyor, soluk ve korkuyor. Başka bir odada Frau Vogel (74) birden ağız kenarı sarkıyor ve belirsiz konuşuyor.

Aufgabe 1 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie die Verdachtsdiagnose bei Herrn Berg und bei Frau Vogel.
TR: Herr Berg ve Frau Vogel için ön tanıyı saptayın.

Antwort: Herr Berg: Verdacht auf Herzinfarkt. Frau Vogel: Verdacht auf Schlaganfall.
Cevap: Herr Berg: kalp krizi şüphesi. Frau Vogel: inme şüphesi.

Aufgabe 2 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei weitere Zeichen für einen Herzinfarkt.
TR: Kalp krizi için üç belirti daha sayın.

Antwort: Enge in der Brust, Atemnot, Übelkeit (auch Schmerzen im Rücken, Kiefer oder Oberbauch). Bei Frauen sind die Zeichen oft anders.
Cevap: Göğüste daralma, nefes darlığı, bulantı (ayrıca sırt, çene veya üst karın ağrısı). Kadınlarda belirtiler çoğu zaman farklıdır.

Aufgabe 3 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei Zeichen für einen Schlaganfall.
TR: İnme için üç belirti sayın.

Antwort: Hängender Mundwinkel, plötzliche Lähmung von Arm oder Bein auf einer Seite, Sprachstörung. (Auch: Sehstörung, starker Schwindel.)
Cevap: Sarkık ağız kenarı, bir tarafta kol veya bacakta ani felç, konuşma bozukluğu. (Ayrıca: görme bozukluğu, şiddetli baş dönmesi.)

Aufgabe 4 – BESCHREIBEN | AFB I
Beschreiben Sie, was die Pflegekraft in beiden Fällen sofort macht.
TR: Hemşirenin her iki durumda hemen ne yaptığını betimleyin.

Antwort: Sie bleibt ruhig und lässt die Person nicht allein. Sie holt sofort Hilfe und den Notruf oder das Notfallteam. Sie beobachtet Bewusstsein, Atmung und Kreislauf.
Cevap: Sakin kalır ve kişiyi yalnız bırakmaz. Hemen yardım ve acil çağrı veya acil ekip çağırır. Bilinç, solunum ve dolaşımı izler.

Aufgabe 5 – ZUORDNEN | AFB I
Ordnen Sie zu: hypovolämisch – kardiogen – obstruktiv – distributiv. a) Lungenembolie b) Blutverlust c) Sepsis d) Herzinfarkt
TR: Eşleştirin: hipovolemik – kardiyojenik – obstrüktif – distributif. a) akciğer embolisi b) kan kaybı c) sepsis d) kalp krizi

Antwort: hypovolämisch → b. kardiogen → d. obstruktiv → a. distributiv → c.
Cevap: hipovolemik → b. kardiyojenik → d. obstrüktif → a. distributif → c.

Aufgabe 6 – ANWENDEN | AFB II
Wenden Sie an: Berechnen Sie den Schockindex. Puls 120, Blutdruck systolisch 80. Was bedeutet das?
TR: Uygulayın: Şok indeksini hesaplayın. Nabız 120, sistolik tansiyon 80. Bu ne anlama gelir?

Antwort: 120 geteilt durch 80 ist 1,5. Der Wert ist hoch (ab 1 wahrscheinlich Schock). Das ist ein schwerer Schock. Man ruft sofort den Notruf.
Cevap: 120 bölü 80 = 1,5. Değer yüksek (1'den itibaren şok olası). Bu ağır şoktur. Hemen acil çağrı yapılır.

Aufgabe 7 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie, warum eine Lungenembolie nach einer Operation passieren kann.
TR: Akciğer embolisinin ameliyattan sonra neden olabileceğini açıklayın.

Antwort: Nach einer Operation liegt man viel. Das Blut fließt langsam. In den Beinvenen kann ein Gerinnsel entstehen. Das Gerinnsel geht mit dem Blut in die Lunge.

Cevap: Ameliyattan sonra çok yatılır. Kan yavaş akar. Bacak venlerinde pıhtı oluşabilir. Pıhtı kanla akciğere gider.

Fallbeispiel 14: Dokümantasyon

Situation (DE): Die Schülerin Nora schreibt in die Akte: „Herr Ott war heute komisch drauf. Er hat Fieber. Wurde mobilisiert.“ In Wirklichkeit ist Herr Ott um 10 Uhr schwindelig geworden. Die Mobilisation wurde abgebrochen. Seine Temperatur war 38,5 °C (axillar). Er sagte: „Mir ist so schlecht.“
Durum (TR): Stajyer Nora kayda şunu yazıyor: „Herr Ott bugün tuhaftı. Ateşi var. Mobilize edildi.“ Gerçekte Herr Ott saat 10'da başı döndü. Mobilizasyon yarıda kesildi. Isısı 38,5 °C (axillar) idi. „Kendimi çok kötü hissediyorum.“ dedi.

Aufgabe 1 – ERMITTELN | AFB II
Ermitteln Sie drei Fehler in Noras Eintrag.
TR: Nora'nın kaydındaki üç hatayı saptayın.

Antwort: 1. „komisch drauf“ ist nicht genau. 2. Kein Messwert und keine Uhrzeit. 3. „Wurde mobilisiert“ stimmt nicht: Die Mobilisation wurde abgebrochen.
Cevap: 1. „tuhaf“ kesin değil. 2. Ölçüm değeri ve saat yok. 3. „Mobilize edildi“ doğru değil: mobilizasyon yarıda kesildi.

Aufgabe 2 – ERKLÄREN | AFB II
Erklären Sie den Unterschied zwischen Beobachtung und Interpretation.
TR: Gözlem ile yorum arasındaki farkı açıklayın.

Antwort: Beobachtung: Ich schreibe, was ich sehe, messe oder höre. Interpretation: Ich schreibe meine Meinung. In der Akte schreibt man Beobachtungen.
Cevap: Gözlem: gördüğümü, ölçtüğümü veya duyduğumu yazarım. Yorum: kendi düşüncemi yazarım. Kayda gözlemler yazılır.

Aufgabe 3 – ENTWICKELN | AFB III
Entwickeln Sie einen richtigen Eintrag.
TR: Doğru bir kayıt geliştirin.

Antwort: „10:00 Uhr: Herr Ott wird bei der Mobilisation schwindelig. Mobilisation abgebrochen. Er sitzt an der Bettkante. Temperatur 38,5 °C axillar. Er sagt: ‚Mir ist so schlecht.‘ Pflegefachkraft informiert.“
Cevap: „Saat 10:00: Herr Ott mobilizasyonda başı dönüyor. Mobilizasyon yarıda kesildi. Yatak kenarında oturuyor. Isı 38,5 °C axillar. ‚Kendimi çok kötü hissediyorum.‘ diyor. Sorumlu hemşire bilgilendirildi.“

Aufgabe 4 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum man nur dokumentiert, was man wirklich gemacht hat.
TR: Neden yalnızca gerçekten yapılanın dokümante edildiğini gerekçelendirin.

Antwort: Andere Personen verlassen sich auf die Akte. Falsche Einträge sind gefährlich für den Patienten. Außerdem ist das ein Fehler gegen die Wahrheit.
Cevap: Başkaları kayda güvenir. Yanlış kayıtlar hasta için tehlikelidir. Ayrıca bu gerçeğe aykırı bir hatadır.

Aufgabe 5 – DEFINIEREN | AFB I
Definieren Sie „Pflegedokumentation“.
TR: „Pflegedokumentation“ (bakım dokümantasyonu) kavramını tanımlayın.

Antwort: Die Pflegedokumentation ist der schriftliche Nachweis über Beobachtungen, Pflegemaßnahmen und Ergebnisse.
Cevap: Bakım dokümantasyonu, gözlemlerin, bakım önlemlerinin ve sonuçların yazılı kanıtıdır.

Aufgabe 6 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie drei Regeln für gute Dokumentation.
TR: İyi dokümantasyon için üç kural sayın.

Antwort: Objektiv schreiben. Zeit, Befund und Maßnahme nennen. Aussagen des Patienten in Anführungszeichen schreiben.
Cevap: Nesnel yazmak. Zaman, bulgu ve önlemi belirtmek. Hastanın sözlerini tırnak içinde yazmak.

Fallbeispiel 15: Yeterlilik ve yasal temel (PflBG)

Situation (DE): Im Unterricht spricht die Lehrerin über das Pflegeberufegesetz. Eine Schülerin fragt: „Machen Pflegekräfte nur, was der Arzt sagt?“ Dann liest die Lehrerin drei Situationen vor: a) Die Pflegefachkraft erhebt den Pflegebedarf. b) Die Pflegefachkraft hilft nach Plan beim Waschen. c) Die Pflegefachkraft prüft die Qualität der Pflege.
Durum (TR): Derste öğretmen Pflegeberufegesetz'den (Hemşirelik Meslekleri Yasası) bahsediyor. Bir öğrenci soruyor: „Hemşireler sadece doktorun dediğini mi yapar?“ Sonra öğretmen üç durum okuyor: a) Hemşire bakım ihtiyacını saptar. b) Hemşire plana göre yıkamada yardım eder. c) Hemşire bakım kalitesini kontrol eder.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie die vier Kompetenzbereiche aus Ihrem Lernskript.
TR: Lernskript'inizdeki dört yeterlilik alanını sayın.

Antwort: Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz.
Cevap: Mesleki yeterlilik, yöntem yeterliliği, sosyal yeterlilik ve kişisel yeterlilik.

Aufgabe 2 – ZUORDNEN | AFB I
Ordnen Sie zu: Welche Situation (a, b, c) ist eine vorbehaltene Aufgabe nach § 4 PflBG?
TR: Eşleştirin: Hangi durum (a, b, c) § 4 PflBG'ye göre saklı bir görevdir?

Antwort: a ist vorbehalten (Pflegebedarf erheben). c ist vorbehalten (Qualität sichern). b ist nicht automatisch vorbehalten (Durchführung nach Plan).
Cevap: a saklıdır (bakım ihtiyacını saptamak). c saklıdır (kaliteyi güvence altına almak). b otomatik olarak saklı değildir (plana göre uygulama).

Aufgabe 3 – NENNEN | AFB I
Nennen Sie die drei vorbehaltenen Aufgaben.
TR: Üç saklı görevi sayın.

Antwort: 1. Pflegebedarf erheben und Pflege planen. 2. Pflegeprozess organisieren und steuern. 3. Qualität der Pflege prüfen und sichern.
Cevap: 1. Bakım ihtiyacını saptamak ve bakımı planlamak. 2. Bakım sürecini organize etmek ve yönetmek. 3. Bakım kalitesini kontrol etmek ve güvence altına almak.

Aufgabe 4 – BEGRÜNDEN | AFB III
Begründen Sie, warum die Aussage „Pflegekräfte machen nur, was der Arzt sagt“ nicht stimmt.
TR: „Hemşireler sadece doktorun dediğini yapar“ ifadesinin neden doğru olmadığını gerekçelendirin.

Antwort: Pflegefachpersonen sind für den Pflegeprozess verantwortlich. Sie planen, steuern und prüfen die Pflege selbst. Sie arbeiten auch mit Ärzten zusammen.
Cevap: Hemşireler bakım sürecinden sorumludur. Bakımı kendileri planlar, yönetir ve kontrol eder. Ayrıca doktorlarla iş birliği yapar.

Aufgabe 5 – DEFINIEREN | AFB I
Definieren Sie „Handlungskompetenz“.
TR: „Handlungskompetenz“ (eylem yetkinliği) kavramını tanımlayın.

Antwort: Handlungskompetenz heißt: Man kann sich im Beruf sachgerecht und verantwortlich verhalten.
Cevap: Eylem yetkinliği şu demektir: Meslekte uygun ve sorumlu davranabilmek.

Aufgabe 6 – ANWENDEN | AFB II
Wenden Sie an: Geben Sie ein Beispiel für Sozialkompetenz bei einem Patienten.
TR: Uygulayın: Bir hastayla ilgili sosyal yeterliliğe örnek verin.

Antwort: Die Pflegekraft hört zu, ist freundlich und erklärt alles verständlich. Sie achtet die Wünsche des Patienten.
Cevap: Hemşire dinler, nazik davranır ve her şeyi anlaşılır açıklar. Hastanın isteklerine saygı gösterir.

Aufgabe 7 – STELLUNG BEZIEHEN | AFB III
Nehmen Sie Stellung: „Nur Pflegefachpersonen müssen den Pflegeprozess kennen.“
TR: Görüş bildirin: „Bakım sürecini yalnızca hemşireler bilmek zorundadır.“

Antwort: Das stimmt nicht. Die Planung und Steuerung gehören den Pflegefachpersonen. Aber auch Auszubildende müssen den Pflegeprozess kennen. Sie führen Maßnahmen durch und beobachten. Sie arbeiten im Team.
Cevap: Bu doğru değil. Planlama ve yönetim hemşirelere aittir. Ama stajyerler de bakım sürecini bilmelidir. Önlemleri uygular ve gözlem yaparlar. Ekip içinde çalışırlar.